

Fecha Última Actualización: 03-07-2023 16:05:20

Página 1 de 3

Información Paciente

Nombre : Leonel Rodolfo Riveros Fuenzalida
Edad : 56a 9m 2d
Dirección : Laguna San Rafael 05551

Rut : 10.851.209-1
Fecha Nacto: 01/10/1966
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 2224700
Sexo : Masculino
Teléfono : 944798599

N° Epicrisis
358236

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Cirugía Sector B - Mediana Compleji
Unidad de Egreso : Cirugía Sector A - Alta Complejidad

Fecha Ingreso : 10/06/2023 20:58
Fecha Egreso : 03/07/2023 16:07

Días Estadía: 23

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

Sd febril

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

Paciente con antecedente de THO 19/02/23, con multiples complicaciones postoperatorias: ACV Hemorragico. Portador de MCP. Infecciones por C. difficile, Sepsis por E. Coli. Presenta caída de nivel hace 1 semana con fractura de humero compleja en tratamiento ortopedico y seguimiento ambulatorio.

Evoluciona febril en domicilio hasta 39.5 por lo que consulta en servicio de urgencia.

Al examen paciente en buena condiciones generales, afebril, desorientado, hidratado bien perfundido, niega nauseas, niega dolor abdominal, sin signos de irritacion peritoneal. Al laboratorio con parametos inflamatorios elevados PCR 186, pruebas hepaticas normales, funcion renal normal. Se decide hospitalización para estudio y manejo.

Se inicia antibioterapia empirica con Meropenem + Vancomicina VO (FI 11/06), se mantiene terapia inmunosupresora (Pred 10, Tacro 3-2, niveles 17/06 2.0). Se aísla en un unico HC una E. Coli MS, es evaluado por infectologia se decide traslape a Ertapenem dado sospecha de BLEE, HC control negativos. Se complementa estudio con TC TAP informado sin hallazgos patologicos, TC de columna total informe pendiente, urocultivo negativo, Ecocardio TT informado con vegetaciones en relación a marcapso. Se diagnostica Endocarditis bacteriana por E Coli, es evaluado por infectologia, se ajusta antibioterapia a Ceftriaxona 2 gr cada 12 hrs IV y se indica evaluación por cardiologia. Evaluado por cardiologia y cardiocirugia, se indica eventual retiro de marcapaso y se solicita Ecocardiograma TE para planificación quirurgica. Se realiza examen el 30/06, informado sin vegetaciones, se descarta Endocarditis bacteriana, sin indicacion de retiro de MCP. Es reevaluado por infectologia, se indica suspender antibioterapia y alta.

Evoluciona con buena respuesta clinica, mas orientado en TE y con parametros inflamatorios a la baja PCR control 8. Estudio de ingreso con PCR CMV positiva 31.300 copias, se inicia Valganciclovir (FI 14/06), PCR CMV control semanal a la baja, último en 6.000 copias. Evaluado por traumatologia, impresiona evolución favorable, continuar con manejo ortopedico y control en 2 semanas con nueva radiografia.

Dado evolución favorable, se decide alta con hospitalización domiciliaria para continuar terapia antibiotica y controles ambulatorios con infectologia, traumatologia y hepatologia.

Fecha Epicrisis : 03/07/2023 16:05

Página 1 de 3

Fecha de Impresión : Martes, 05 de Mayo de 2026 17:56

Usuario Impresión : Andres Aquevedo Salazar

Fecha Última Actualización: 03-07-2023 16:05:20

Página 2 de 3

Resumen Laboratorio

18/06 Hb 10.5 GB 4.580 PlaQ 191.000 PCR 8 (10) BT 0.43 BD 0.18 FA 118 GGT 43 GOT 24 GPT 47 INR 1.05 Crea 0.43 BUN 12 Na 139 K 4.75 Cl 103 P 3.4 Mg 1.6 Prealb 20

16/06 Hb 9.1 GB 3.870 PlaQ 170.000 PCR 17 (25) BT 0.41 BD 0.18 FA 105 GGT 41 GOT 21 GPT 37 INR 1.13 Crea 0.43 BUN 8.1 Na 143 K 4.03 Cl 108 P 2.6 Mg 1.6

15/06 Hb 9.9 GB 4.190 PlaQ 165.000 PCR 25 (32) BT 0.34 BD 0.14 FA 115 GGT 44 GOT 24 GPT 40 INR 1.18 Crea 0.46 BUN 7 Na 140 K 3.5 Cl 106 P 3.2 Mg 1.5

Estudio microbiológico

PCR 11/06 CMV 31.300 copias

HC 11/06 1 (+) E. Coli MS, 2 pendiente

HC 14/06 pendientes

PCR covid negativo

Panel respiratorio negativo

OC no inflamatoria,
UC negativo

Eco mege 12/06: Escaso liquido libre intraabdomianl. VB sin dilatación.
Rx hombro tomada. Pendiente evaluación por TMT.
Ecocardiograma: pendiente informe.

TC Columna: pendiente informe.

TC TAP 14/06: Cambios postquirúrgicos de trasplante hepático. Edema periportal.
Escasa ascitis perihepática. Nefritis bilateral, de posible origen inflamatorio infeccioso.
Signos sugerentes de proctitis estercorácea. Nefrolitiasis puntiforme izquierda no obstructiva. Fractura impactada en el cuello humeral derecho. Leve derrame pleural bilateral.

Diagnóstico de Egreso

Fiebre De Origen Desconocido -
Transplante De Hígado -
Fractura De La Epífisis Superior Del Húmero -

Condición de Egreso Alta Hosp. Domiciliaria

Egreso con Catéter Doble J: NO

Buenas condiciones generales.

Plan Post Alta

- Reposo relativo. No hacer cama. Levantar a silla diariamente.
- Regimen comun + 1 suplemento/dia
- Continuar rehabilitación con kinesioterapia

Fecha Epicrisis : 03/07/2023 16:05

Página 2 de 3

Fecha Última Actualización: 03-07-2023 16:05:20

Página 3 de 3

- Medicamentos:

Tacrolimus, 3 mg AM (09:00 hrs) - 2 mg PM (21:00 hrs) VO a permanencia

Prednisona 10 mg/día, VO a permanencia

PEG, disolver 1 sobre en 200 cc de agua, tomar 2 veces al día VO, a permanencia

Cotrimoxazol forte, 1 comprimido los lunes, miercoles y viernes, VO

Elcal-D 2 comprimidos al día VO a permanencia

Magnatil 1 comprimido al día VO a permanencia

Atorvastatina 40 mg al día VO.

Quetiapina 25 mg noche VO.

- Control con Dra. Dominguez (Hepatología) Martes 11/07 a las 15:00 horas.
Acudir con exámenes tomados lunes 10/07 a las 9 AM en unidad trasplante hepático.

- Control con Dr. Kameid (Traumatología) en 1 semana. Pedir hora en CDT con anticipación.
(Radiografía en sistema). IC cursada (se entrega).

- Consultar en servicio de urgencia en caso de fiebre mayor a 37.5 grados, dolor abdominal que no cede con analgesia, náuseas y vómitos persistentes, sangrado, coloración amarilla de piel y ojos, dificultad respiratoria o cuando estime conveniente.

Indicaciones

Tipo de Reposo :

Régimen Alimentario :

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Javier Salinas Sánchez

Becado/Residente

Alfonso Díaz Fernandez

Médico Tratante (Staff)

Fecha Epicrisis : 03/07/2023 16:05

Página 3 de 3